

약품명(성분명)(용량)	투여용량	dilution/mix방법	주의사항
Cardio			
Perdipine (Nicardipine) (10mg/10cc)	IVs: 1 mg C.I: 1 mg/hr *TS: 0.1 mcg/kg/min ~ (bolus 100mcg ± 0.1cc)	0.5mg/cc (central line) (5@ + N/S or D5W 50cc) = 50mg/100cc 0.2mg/cc (peri route) (2@ + N/S or D5W 40cc) = 20mg/100cc 0.1mg/cc (peri route) (2@ + N/S or D5W 180cc) = 20mg/200cc	phlebitis 잘 생김. 말초정맥 사용 시 12시간 마다 route change ※0.1-0.2mg/cc 희석권고
Labesin (Labetalol) (100mg/20cc) *trandate라고 많이 불림	IVs: 10-20 mg (max 50mg) over 1-2min. 반복투여가능(Max. total 200mg) C.I: 1 mg/hr	1mg/cc (2@ + N/S or D5W 160cc) = 200mg/200cc	phlebitis 잘 생김. 말초정맥 사용 시 12시간 마다 route change. 서맥 유발.
Herben (Diltiazem) (50mg)	IVs: 1 mg C.I: 1 mg/hr	1mg/cc (1vial + N/S or D5W 50cc) = 50mg/50cc	서맥, 저혈압 유발
Nitrolingual (Nitroglycerin) (50mg/50cc)	C.I: 10 mcg/min ~ *TS: 0.1 mcg/kg/min ~	0.2mg/cc (1vial + N/S or D5W 200cc) = 50mg/250cc	빈맥, 저혈압 유발 (PVC에 흡착되므로 non PVC line, bag 사용)
Cordarone (Amiodarone) (150mg/3cc)	Loading: 150mg or 300mg + D5W 100cc over 30min C.I: 150 mg/day ~	1.5mg/cc 5@ (2@ + D5W 140cc) = 300mg/200cc	only D5W 서맥, QT prolongation 유발함. (QT/QTc확인)
Brevibloc (Esmolol) (2.5g/10cc)	IVs: 1 mg (100mg/10cc 사용) C.I: 1 mg/min *TS: 10 mcg/kg/min ~	10mg/cc (1@ + N/S or D5W 240cc) = 2.5g/250cc	저혈압, 서맥 유발
Primacor (Milrinone) (10mg/10cc)	C.I: 0.1mcg/kg/min ~	0.2mg/cc (2@ + N/S or D5W 80cc) = 20mg/100cc	심실 빈맥, 저혈압 유발
Isuprel (Isoproterenol) (0.2mg/1cc)	IVs: 0.2mg + D5W 10cc 천천히 C.I: 0.1mcg/min ~ *TS: 0.01mcg/kg/min ~	4mcg/cc (2@ + D5W 98cc) = 0.4mg/100cc	
2% Lidocaine (400mg/20cc)	IVs: 50-100mg C.I: 1mg/min ~	4mg/cc (1vial + D5W 80cc) = 400mg/100cc	IVs시 1시간동안 max 300mg 까지 가능
Nitropress (Nitroprusside) (50mg/2cc)	C.I: 0.1mcg/kg/min ~ (0.5-10mcg/kg/min)	0.2mg/cc (1vial + D5W 248cc) = 50mg/250cc	차광
Isoket (Isosorbide dinitrate) (10mg/10cc)	C.I: 1 mg/hr ~ (max 10mg) *TS: 0.1mcg/kg/min	0.1-0.2mg/cc 1@ + D5W 90cc ~ 2@+80cc *TS: 0.5mg/cc (5@ + N/S or D5W 50cc) = 50mg/100cc	
Inotropics			
Tropin / Dopamix (premix) (Dopamine) (200mg/5cc)	C.I: 1 mcg/kg/min ~	2mg/cc (premix 있음) (1@ + D5W 95cc) = 200mg/100cc	3mcg 이하는 renal dose로 BP 상승 효과 적음.
Dobutamine (250mg/5cc)	C.I: 1 mcg/kg/min ~	2mg/cc (premix 있음) (1@ + D5W 120cc) = 250mg/125cc	
Norpin (Norepinephrine) (4mg/4cc) *levophed, levo라고 많이 불림	C.I: 1 mcg/min ~ *TS: 0.01mcg/kg/min ~	40mcg/cc (central line) (1@ + D5W 96cc) = 4000mcg/100cc 16mcg/cc (peri route) (1@+D5W 248cc=4000mcg/250cc (2@+D5W 492cc=8000mcg/500cc	only D5W digital necrosis mesenteric blood flow감소 ->말초 color change 되는지 assess필요!
Epinephrine (1mg/1cc)	IVs(CPR시): 0.5-1@ 3-5분마다 E-tube: 2-2.5mg+N/S 5-10ml C.I: 0.01mcg/kg/min ~	10mcg/cc (1@ + N/S 99cc) = 1000mcg/100cc	Anaphylaxis의 경우 0.5@을 허벅지 전측부에 IM, 반응 없을 시 10배 희석하여 1cc IVS
Phenylephrine 1% (10mg/1cc)	IVs: 10 mcg ~ 100mcg (초기량 0.5mg 이내)	1@ + 499cc →40-60mcg/min *TS: 100mcg/cc (1@ + N/S or D5W 99cc)	반복투여시 10-15분 후

• 투여용량의 '10'은 십의자리를 '1'는 일의자리를 '0.1, 0.01'는 소수점 단위의 처방을 표현함. 예) Midazolam 5mg IVs
 •• 약물 mix 시 더 희석은 가능하나 더 농축 필요시약품정보파트(T.2328)로 문의.

2021.04.19 update

약품명(성분명)(용량)	투여용량	dilution/mix방법	주의사항
Emergency (CPR & Intubation)			
Adenocor (Adenosin) (6mg/2cc)	IVs: 6mg →12mg →12mg	현액사용	반갑기가 짧아 심장에서 가까운 route에 주입. 즉시 N/S 20cc이상 빠르게 주입. EKG monitoring!!
Isoptin(Verapamil) (5mg/2cc)	IVs: 1 st 2.5mg-5mg ov. 2min →반응 없으면 15-30분 후 →2 nd 5-10mg(max. 20mg)		
Vasopressin (20unit/1cc)	IVs: epinephrine 대신 40unit ivs C.I: 0.01-0.04 unit/min ~	0.2unit/cc (1@ + D5W 99c)	냉장보관 *1st&2nd epinephrine 대체
Midazolam (3mg/3cc, 5mg/5cc)	IVs: 1 mg cf. 장기간 진정: 0.03-0.2mg/kg을 IV bolus 또는 지속적 정맥주입	현액사용	마약류 필요시 신경근차단제 투여 전 (기관삽관)
Etomidate (20mg/10cc)	IVs: 1-10 mg (0.1mg-0.2mg/kg)	현액사용	필요시 신경근차단제 투여 전 (기관삽관)
Esmeron (Rocuronium) (50mg/5cc)	IVs: 10 mg (0.6mg-1mg/kg)	현액사용	냉장보관 신경근차단제. 기관삽관 시 진정제 투여 후
Naloxone HCl (0.4mg/1ml)	IVs,IM,SC: 0.4-2mg 2-3분 간격 반복 투여 가능 C.I: 0.2-0.6mg/hr	IVs: 1@ + N/S 9cc (=0.4mg/10cc) ov 30sec (slow push) E-tube: 1@ + N/S 1-2ml →NS 5cc flushing (10@ + N/S or D5W 1L (= 0.004-0.008mg/cc)	
Flumazenil (0.3mg/3ml)	IVs: 0.2-0.3mg(15초 이내) → (60초 이내 의식회복 안되면) 0.1mg push (필요시 반복투여, max. 1mg)		
Electrolyte correction			
Calcium gluconate (2g/20cc)	IVs: 0.4g-2g (혈압 저하 시) MIVs: 1 g + N/S 50-100cc	hyperK+교정: D5W에 희석	Bivon과 병용투여 금지 IV bolus 투여 시 주의
Potassium Chloride (40mEq=20cc)	MIVs: KCl 1cc×25 →N/S(cc) 되도록 희석 (NAK를 사용 권장)	K correction = (기준수치 - 환자 lab 수치) × Bwt / 8 cc	말초정맥희석농도 = 80mEq/L IV bolus 투여 금지
10% Magnesium (2g/20cc)	1-2g(max. 2-4g/day)	MIVs: 1g + N/S 50-100cc (10% 이하희석) ov. 30min	IV bolus 투여 금지. 서맥주의
Phosten (KH2P04 13.61%) 2.722g(P 20mmol)/20cc	phosphate level >2 mg/dl되거나 증상이 없을 때까지 교정가능	MIVs: 1@ + N/S 250cc (peri) ov. 1hr	IV bolus 투여 금지, phosten 1@에 potassium 20mEq 섞여있음(투여속도<20mmol/hr)
기타약품			
Sodium Bicarbonate (20mEq/20ml)	1-5g (12-60mEq) IV cf. 2-5mEq/kg q 4-8hrs IV (max 60세이하 200mEq/day, 60세이상 100mEq/day) →hyperK+: 50 mEq IV ov. 5 minutes		→필요량(mEq)=부족열기량 (Base Deficit mEq/L)×0.2×체중(kg)

• 투여용량의 '10'은 십의자리를 '1'는 일의자리를 '0.1, 0.01'는 소수점 단위의 처방을 표현함. 예) Midazolam 5mg IVs
 •• 약물 mix 시 더 희석은 가능하나 더 농축 필요시약품정보파트(T.2328)로 문의.

2021.04.19 update